

胃食管反流综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

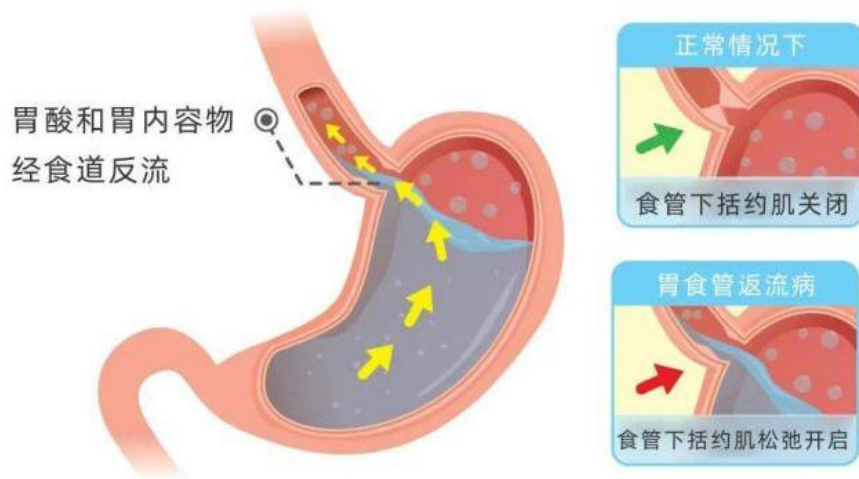
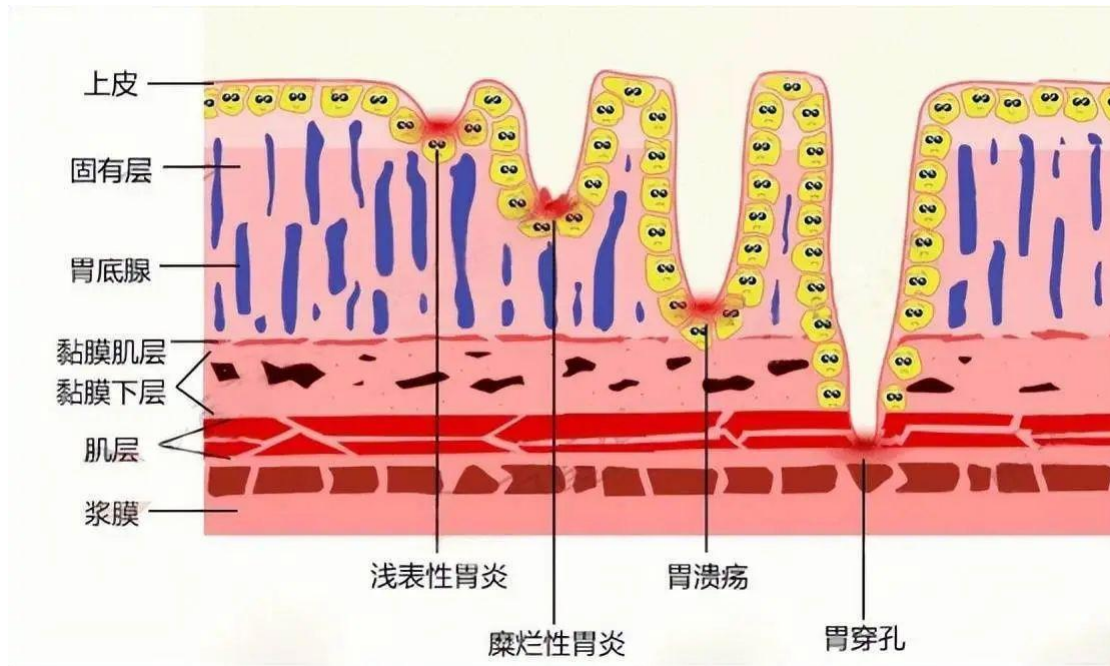
胃食管反流病在全世界范围内发病均较高，整体人群中每周至少发作 1 次烧心的患病率为 13%，亚洲地区近些年升高明显，我国基于人群每周至少发作 1 次烧心症状的患病率为 1.9%-7.0%。胃食管反流病随年龄增加发病概率增加，男女比例接近。

从年龄分布来看，2019 年中国胃食管反流发病率、患病率随着年龄的增长不断上升。过去的二十年中，中国的胃食管反流患病率从 6.0%升高至 10.6%。

该病发病与生活习惯、身体质量指数、生活压力等因素息息相关，具有复发率高、迁延难愈的特点，对患者的生活质量和经济压力造成了严重影响。

胃食管反流可引发多种危害，包括损害食管黏膜、影响生活质量、增加呼吸道疾病风险、可能导致癌变以及与其他疾病相互影响。

胃食管反流作为一种常见的消化系统疾病，其危害不容忽视。患者需重视病情，积极治疗，改善生活习惯，以降低疾病带来的各种风险。



当阀门功能减退时，胃酸及胃内容物就会逆流到食管中。反流的酸性物质刺激食管黏膜，就会出现烧心，甚至胸痛。如果反流的情况经常出现，超过每周两次，就可以诊断为胃食管反流病。

胃食管反流的表现症状多达 70 多种，其中近 30% 表现为消化系统以外症状，所以容易被误诊。

一、引流普筛

1.1 发病原因

根本原因通常是胃酸过低、肠道菌群失衡、幽门螺杆菌感染或食物不耐受。通过饮食调整、促进正常胃酸分泌、改善胃肠动力和减少压力，可以自然缓解胃食管反流，而不依赖药物。

1.2 高危人群

胃食管反流并不是所有人都会发生，但以下人群的风险较高：

生活习惯不好的人群

超重、肥胖或孕妇（腹内压力较大）

长期焦虑、压力大的人（压力可能影响食管括约肌功能）

有幽门螺杆菌感染或消化道功能紊乱的人

长期服用影响下食管括约肌功能的药物（如镇静剂、抗抑郁药等）

高龄人群：50~70 岁年龄段胃食管反流高峰期，随着年龄增加，发病率越来越高。

食管裂孔疝患者：食管裂孔疝是指除食管以外，任何腹腔组织结构通过扩大的膈肌食管裂孔进入胸腔形成的疝。目前认为，食管裂孔疝和胃食管反流有非常大的关系，而食管裂孔疝越大，反流、烧心症状往往越重。

1.3 临床表现

反酸：指胃十二指肠内容物在无恶心和不用力的情况下涌入咽部或口腔的感觉，含酸味时称反酸。这是胃食管反流病最常见的症状之一，患者常常会感觉有一股酸水从胃里涌上喉咙，有时还会伴有苦味。

烧心：即胸骨后或剑突下烧灼感，常由胸骨下段向上延伸。这种烧灼感就像胸口有一团火在燃烧，通常在饭后、弯腰或躺下时会加重，严重影响患者的生活质量。

胸痛：部分患者可能会出现胸痛的症状，这种疼痛可能与心绞痛相似，容易被误诊。但胃食管反流病引起的胸痛通常与饮食有关，比如在进食后或夜间发作，而心绞痛则更多与运动、情绪激动等因素相关。

吞咽困难：长期的胃食管反流可能会导致食管黏膜受损、狭窄，从而出现吞咽困难的症状。患者可能会感觉食物在食管中下行缓慢，甚至有堵塞感。

咽部异物感：反流物刺激咽喉部，会导致患者出现咽部异物感，总觉得喉咙里有东西，咳不出也咽不下，还可能伴有声音嘶哑、慢性咳嗽等症状。

其他症状：胃食管反流病还可能引起一些食管外的表现，如哮喘、慢性咳嗽、特发性肺纤维化、鼻窦炎、复发性中耳炎等。

二、试用

卫平畅试用三天，修复胃上皮细胞，强力修复胃黏膜损伤。缓解反酸恶心症状。

三、诊断

临床常用的胃食管反流诊断问卷包括反流性疾病问卷量表(RDQ)或胃食管反流病问卷量表(GerdQ)。当 RDQ 评分 ≥ 12 分或 GerdQ 评分 ≥ 8 分，认为存在 GERD 的可能性大。

反流性疾病问卷量表（RDQ）（过去 4 周）				
项目	胃灼烧感	反酸	反食	胸骨后疼痛感
发作频率				
无	0	0	0	0
<1d/周	1	1	1	1
1d/周	2	2	2	2
2-3d/周	3	3	3	3
4-5d/周	4	4	4	4
6-7d/周	5	5	5	5
发作程度				
无	0	0	0	0
不明显	1	1	1	1
轻微	2	2	2	2
明显	3	3	3	3
较重	4	4	4	4
非常严重	5	5	5	5

胃食管反流病问卷量表（GerdQ）（过去 1 周）				
	无	1-2d/周	2-3d/周	4-7d/周
胸骨后灼烧感/烧心	0	1	2	3
胃内容物反流	0	1	2	3

上腹部中央疼痛	3	2	1	0
恶心	3	2	1	0
因烧心或反酸难以获得良好的睡眠	0	1	2	3
除医师告知的药物外，还需额外服用其他药物缓解烧心或反酸	0	1	2	3

并结合医院胃镜检查、食管动态胃酸监测、食管测压等检测指标确诊。

四、干预和治疗

胃食管反流病治疗目标：

- ①诱导并维持病情缓解，包括临床症状缓解、食管黏膜组织修复；
- ②预防病情复发，改善患者生存质量；
- ③减少并发症。

产品名称	作用机理
清畅/畅快	调节肠道菌群，降低炎症反应。对胃粘膜保护、抑制幽门螺旋杆菌有较好的作用。 畅快调节肠道菌群通过脑肠轴作用 5-羟色胺，调节胃酸分泌。
卫平畅	修复胃上皮细胞，强力修复胃黏膜损伤。 抑制幽门螺杆菌在胃黏膜附着，减少对胃粘膜损伤。
安欣畅	提高睡眠质量。晚上熟睡时分泌量更大量的 TFF 蛋白，能在胃黏膜上形成一种黏液膜，一方面能减少坚硬物质损伤胃黏膜，另一方面，其是弱碱性的，能有效阻止胃酸对

	胃黏膜的腐蚀作用。 促进 5-羟色胺分泌，促使乙酰胆碱释放，产生胃肠道动力的作用。
纽畅伴侣 高蛋白	蛋白质是构成胃黏膜的重要成分，有助于修复受损的胃壁。高蛋白食物有助于维持胃黏膜的完整性，保护胃部免受胃酸和消化酶的侵蚀。

综合方案	
清畅/畅快：早餐前约半小时 1 袋 纽畅伴侣高蛋白：每次餐前约 10g 卫平畅：晚餐前约半小时 1 袋 安欣畅：睡前约 1 小时 1 袋	
本方案的核心点是保护胃粘膜调节胃酸分泌，故而对胃粘膜造成损伤的如幽门螺杆菌、胃溃疡、胃炎等都适用。另外由于胃部不适引起的消化不良和长期使用对胃容易造成损伤的药物等同样可适用本方案。	

五、康复管理

氢医疗：氢气能够中和体内的有害自由基，减轻炎症反应，并促进胃黏膜的修复。氢气能够保护胃黏膜免受胃酸和酒精等刺激性物质的伤害。有临床研究显示，长期饮用富氢水的胃炎患者，胃痛、腹胀等症状的改善率高达 80%以上，这显示了氢气在治疗胃痛和胃炎方面的潜力。

每日持续吸氢不低于 30 分钟，最好每日 2 次。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录分析。

胃食管反流-诊疗案例调查表

基本信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	出生日期	年 月 日
	身高	cm	体重	kg	联系电话	
	联系地址					
病情描述	1、现在有哪些症状？（ ） A 反酸 B 烧心 C 胸痛 D 吞咽困难 E 腹胀、腹痛 F 咽部异物感 G 口干、口苦、口臭 H 咳嗽、哮喘等 2、检测指标 C13/C14_____胃蛋白酶原I（PGI）_____ 胃蛋白酶原II（PGII）_____ 3、其他内容 _____ _____					
诊疗方案	营养干预方案	☐ 早：_____益生元，_____袋				开始服用时间
		☐ 午：_____益生元，_____袋				
		☐ 晚：_____益生元，_____袋				服用周期
		☐ 睡前：_____益生元，_____袋				
	药物方案					
其他建议						
评估人/诊所：					评估日期	
干预后改善情况	1、体感变化 _____ _____					
	2、检测指标 C13/C14_____胃蛋白酶原I（PGI）_____ 胃蛋白酶原II（PGII）_____					
评估人/诊所：					评估日期	